



100020



发文日:

2023 年 03 月 29 日

申请号或专利号: 201080051819.0

发文序号: 2023032400207240

案件编号: 4W114879

发明创造名称: 治疗增殖性障碍和其它由 BCR-ABL、C-KIT、DDR1、DDR2 或 PDGF-R 激酶活性介导的病理学病症的方法

专利权人: 诺华股份有限公司

无效宣告请求人: 苏州特瑞药业股份有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 560109 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定,国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查,现决定如下:

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定,对本决定不服的,可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉,对方当事人作为第三人参加诉讼。

附:决定正文 12 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长: 王冬

主审员: 潘珂

参审员: 刘琳



201019 纸件申请,回函请寄:100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收

2022.10 电子申请,应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外,以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



国家知识产权局

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 560109 号)

案件编号	第 4W114879 号
决定日	2023 年 03 月 27 日
发明创造名称	治疗增殖性障碍和其它由 BCR-ABL、C-KIT、DDR1、DDR2 或 PDGF-R 激酶活性介导的病理学病症的方法
国际分类号	A61K 31/506, A61P 35/00, A61K 9/00
无效宣告请求人	苏州特瑞药业股份有限公司
专利权人	诺华股份有限公司
专利号	201080051819.0
申请日	2010 年 11 月 17 日
优先权日	2009 年 11 月 17 日
授权公告日	2014 年 03 月 05 日
无效宣告请求日	2022 年 08 月 22 日
法律依据	专利法第 26 条第 4 款
决定要点: 权利要求能够给予保护的应当与发明的实际贡献相匹配, 以将其与现有技术进行合理划界, 以免损害公共利益。判断权利要求的概括是否合理, 应客观分析说明书所充分公开的内容并结合本领域技术人员对现有技术状况的整体理解进行评价, 如果权利要求的限定中包含了申请人推测的内容, 基于说明书记载即使考虑了本领域技术人员的知识和能力也依然难于预先确定和评价其效果, 则不应允许将权利要求扩展至所述保护范围。	



一、案由

涉案专利的专利号为 201080051819.0，优先权日为 2009 年 11 月 17 日，申请日为 2010 年 11 月 17 日，授权公告日为 2014 年 03 月 05 日。涉案专利授权公告时的权利要求书如下：

“1. 作为一水合物的 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基氨基)-苯甲酰胺的盐酸盐在制备用于治疗慢性粒细胞白血病的药物中的用途，其中所述的作为一水合物的 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基氨基)-苯甲酰胺的盐酸盐和可药用载体分散在苹果酱中。”

关于术语，权利要求 1 中的“一水合物的 4-甲基-N-[3-(4-甲基-咪唑-1-基)-5-三氟甲基-苯基]-3-(4-吡啶-3-基-嘧啶-2-基氨基)-苯甲酰胺的盐酸盐”在下文也称为“尼洛替尼”或“尼罗替尼”、“慢性粒细胞白血病”在下文也称为“CML”。

苏州特瑞药业有限公司（下称请求人）于 2022 年 08 月 22 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是涉案专利权利要求 1 不符合专利法第 22 条第 2、3 款和专利法第 26 条第 4 款的规定，请求宣告涉案专利全部无效，同时提交了如下证据的打印件或复印件：

证据 1：尼洛替尼（Tasigna®）英文药品说明书（2009.09.01 FDA 批准修订版），及其部分内容中文译文；

证据 2：公开号为 CN101516344A 的中国发明专利申请公开文本；

证据 3：European Medicines Agency Decision of 27 March 2009（Doc.Ref.EMA/161203/2009 P/60/2009，即欧洲药品管理局（EMA）2009 年 03 月 27 日发布的一项关于批准尼洛替尼儿童用药研究方案的决定），及其部分内容中文译文；

证据 4：ROBERT G.STRICKLEY 等人，Pediatric Drugs—A Review of Commercially Available Oral Formulations”，Journal of Pharmaceutical Sciences，第 97 卷第 5 期，第 1731-1774 页，2008 年 05 月 01 日，第 19-21 页，打印件及其部分中文译文；

证据 5：食物对生物利用度的影响以及餐后生物等效性研究技术指导原则，2002 年 12 月美国 FDA 发布，2009 年 6 月药审中心组织翻译，封面页、目录页、第 1-8 页；

证据 6：Guidance for Industry Food—Effect Bioavailability and Fed Bioequivalence Studies（证据 5 的英文原版），美国 FDA 2002 年 12 月发布，封面页、目录页、第 1-9 页；

证据 7：道格拉斯·C. 奈克等著，金寄春等译，《有机化学（上册）》，化学工业出版社，1984 年 11 月北京第 1 版，1984 年 11 月北京第 1 次印刷，封面页、版权信息页、译者前言页、目录页、第 347-348 页；

证据 8：陈琼主编，《中药制剂技术》，中国农业大学出版社，2009 年 8 月第 1 版，2014 年 1 月第 4 次印刷，封面、扉页、参考文献页、版权信息页、目录页、第 143-144 页；

证据 9：Flomax®胶囊（04mg）的英文药品说明书，2006 年，及其部分内容中文译文；



证据 10: 司美替尼 (Selumetinib) 胶囊的英文药品说明书, 2020 年, 及其部分内容中文译文;

证据 11: Flomax®临床药理学英文评审报告, 2009 年 06 月 25 日, 及其部分内容中文译文;

证据 12: Sarit Cohen-Rabbie 等人, Effect of food on capsule and granule formulations of selumetinib, Clin Transl Sci. (2022); 00, 第 1-11 页, 2022 年 02 月 15 日, 及其部分内容中文译文;

证据 13: 李雪宁等人, 葡萄袖汁与药物的相互作用, 《中国临床药理学杂志》, 1999 年, 第 15 卷第 5 期, 第 389-393 页;

证据 14: Eric T Wittbrodt 等人, Delayed release dexlansoprazole in the treatment of GERD and erosive esophagitis, Clinical and Experimental Gastroenterology, 2009 年, 第 117-125 页, 及其部分内容中文译文;

证据 15: Jamie D. Croxtall 等人, Esomeprazole In Gastroesophageal Reflux Disease in Children and Adolescents, Pediatr Drugs, 2005 年, 第 10 卷, 第 3 期, 第 199-205 页, 及其部分内容中文译文;

证据 16: Tracy Swainston Harrison 等人, Extended-Release Carbamazepine Capsules in Bipolar I Disorder, Am J Drug Deliv, 2006 年, 第 4 卷, 第 1 期, 第 51-55 页, 及其部分内容中文译文;

证据 17: 关于 Tasigna 的 EPAR scientific Discussion, 欧洲药品管理局发布, 可获得自网站 https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-discussion/tasigna-epar-scientific-discussion_en.pdf, 2007 年, 及其部分内容中文译文;

证据 18: 涉案专利的国际公开文本 W02011 / 062927A1, 公开日为 2011 年 5 月 26 日, 及其部分内容中文译文;

证据 19: 欧洲药品管理局 (EMA) 下属人用医药产品委员会 (CHMP) 指导性意见: Reflection paper: Formulations of Choice For The Paediatric population, 2006 年, 及其部分内容中文译文;

证据 20: F Brion 等人, Extemporaneous (magistral) preparation of oral medicines for children In European hospitals, Acta Paediatr., 2003 年, 第 92 卷, 第 4 期, 第 456-490 页, 及其部分内容中文译文;

证据 21: Milap C. Nahata 等人, Extemporaneous Drug Formulations. Clinical Therapeutics, 2008 年, 第 30 卷, 第 11 期, 第 2112-2119 页, 及其部分内容中文译文;

证据 22: DRAFT Guidance, Use of Liquids and/or soft foods as vehicles for drug administration: General considerations for selection and in vitro methods for product quality assessments, Guidance for Industry, 2018 年 07 月, 及其部分内容中文译文;

证据 23: Size of beads in drug products labeled for sprinkle, Guidance for Industry, 2012 年 05 月, 及其部分内容中文译文;

证据 24: Ramu Ivaturi 等人, Development and validation of a stability indicating HPLC method For the determination of nilotinib hydrochloride in bulk and Pharmaceutical dosage form, Int J Pharm & Pharm Sci, 2016



年，第 8 卷，第 9 期，第 41–48 页，及其部分内容中文译文；

证据 25: Tasigna (nilotinib) capsules 的用药说明，2011 年 1 月，及其部分内容中文译文；

证据 26 : Maitreyee Hazarika 等人 , Tasigna for Chronic and Accelerated Phase Philadelphia Chromosome–Positive Chronic Myelogenous Leukemia Resistant to or Intolerant of Imatinib. Clin Cancer Res. , 第 14 卷，第 17 期，2005 年 09 月 01 日，第 5325–5331 页，及其部分内容中文译文；

证据 27: 朱照静、张炳盛、周金彩主编，《药剂学》，第四军医大学出版社，2007 年 08 月第 1 版，2007 年 08 月第 1 次印刷，封面页、版权信息页、目录页、第 472–474 页；

证据 28: 王九辉主编，《临床药理学概论》，海南出版社，2008 年 06 月第一版，2008 年 06 月第 1 次印刷，封面页、版权信息页、目录页、第 149–第 151 页；

证据 29: 魏树礼主编，《生物药剂学与药物动力学》，北京医科大学、中国协和医科大学联合出版社，1997 年 10 月第 1 版，1997 年 10 月山东第 1 次印刷，封面页、版权信息页、目录页、第 144 页；

证据 30: Kevin A. Wells 等人 , In Vitro Stability, Potency, and Dissolution of Duloxetine Enteric–Coated Pellets After Exposure to Applesauce, Apple Juice, and Chocolate Pudding, Clinical Therapeutics, 2008 年，第 30 卷，第 7 期，第 1300–1308 页，及其部分内容中文译文；

证据 31: 专利权人在涉案专利的前次无效宣告程序中的转送文件通知书及所转送的文件；

证据 32: 专利权人在涉案专利的欧洲同族专利的异议程序中的意见陈述。

请求人认为：

(1) 证据 1–2 已公开了包含尼罗替尼（商品名 Tasigna）和明胶、氧化铁等常规辅料的口服胶囊用于治疗慢性期（CP）和急变期（AP）CML 的用途，“分散在苹果酱中”是用药特征而非制药特征。结合证据 18、证据 19–23、权利要求 1 的限定，以及说明书可以确认“其中所述的……的盐酸盐和可药用载体分散在苹果酱中”属于尼罗替尼的给药方式，对于制药用途并无实质限定作用。从证据 7、证据 24、证据 22 附录 A、证据 30 摘要以及证据 25 可知，苹果酱也无法作为药用辅料用于尼罗替尼药物剂型。相对证据 26，权利要求 1 不具备新颖性。即使将权利要求 1 的保护范围理解为尼罗替尼和可药用载体分散在苹果酱中的药物，相对证据 3，权利要求 1 仍不具备新颖性。

(2) 以证据 3 作为最接近的现有技术：权利要求 1 与证据 3 的区别在于证据 3 没有明确尼罗替尼、可药用载体和苹果酱是属于制药过程中得到的药物。涉案专利的试验并没有验证将尼罗替尼、可药用载体、苹果酱三者制得的药物“苹果酱分散物”的生物等效性，且实施例 1 已自证室温方式 15 分钟后，尼罗替尼平均回收率降至最低 97.6%，证据 25 亦佐证这一点。即使不考虑混合制备成药物后药效降低，结合证据 27、28 对生物等效性的定义，可知也无法认定本发明取得了生物等效。证据 32 是欧洲同族专利中专利权人的自认，亦证实生物等效性是与参比产品比较而得的相对手段，目标仅在于证实等量同种药物的两种制剂具有相同的有效



性和安全性（参见证据 27），涉案专利分散于酸奶中生物利用度却得到提高，显然更为有益。因此权利要求 1 实际解决的技术问题仅仅是克服老年或儿科患者吞咽胶囊困难的问题。证据 3 明确教导了尼罗替尼、可药用载体和苹果酱或酸奶混合后可以用于治疗 CML，因此权利要求 1 不具备创造性。

（3）以证据 2 作为最接近的现有技术，区别在于尼罗替尼、可药用载体分散在苹果酱中，证据 4 已公开了多种胶囊内容物与少量松软食物例如苹果酱混合后给药以克服老年或儿科患者吞咽胶囊困难的常规做法。在证据 2 和证据 4 的基础上，或在证据 2 和证据 3 的基础上，权利要求 1 不具备创造性。针对涉案专利的第 54130 号无效决定认为，证据 1 给出了“尼罗替尼和可药用载体分散在苹果酱中”相反的教导，结合证据 5、证据 1、证据 8，证据 4，证据 9，证据 10，证据 11 和证据 12，以及证据 17，证据 13，证据 14–16 请求人认为该决定所述的上述“反向教导”不能成立。以证据 26 作为最接近的现有技术，权利要求 1 与证据 26 的区别在于“尼罗替尼和可药用载体分散在苹果酱中”，实际解决的技术问题仅仅是克服老年或儿科患者吞咽胶囊困难的问题。基于证据 4 或证据 3 的教导，权利要求 1 仍不具备创造性。

（4）结合涉案专利说明书以及证据 31、32、29 可知，涉案专利并未证明尼罗替尼和苹果酱在其他剂量和配比下苹果酱分散物与完整胶囊剂是否仍然具有生物等效性。涉案专利权利要求 1 并未对尼罗替尼和苹果酱的剂量和配比做出任何限定，无法预期权利要求 1 范围内的所有技术方案都能够实现生物等效的技术效果。因此权利要求 1 得不到说明书的支持。如果涉案专利权利要求 1 的保护范围理解为制药过程中得到的药物包含尼罗替尼、可药用载体和苹果酱三种成分，尼罗替尼和可药用载体分散在苹果酱中，三者呈混合存在的状态，“苹果酱”是“可药用载体”的下位概念，上下位概念作为并列选项同时出现在权利要求 1 的技术方案中，导致权利要求 1 的保护范围不清楚。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2022 年 09 月 13 日受理了上述无效宣告请求，并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

2022 年 09 月 13 日，请求人提交了国家图书馆出具的报告编号为 2022-NLC-GCZM-00512 的馆藏复制证明（其中包含证据 2、4、7、8、12、13、20、27–29），（2022）京长安内经证字第 35668 号公证书（其中包含证据 1、6、9–11、14–17、19、21–26、30、32 的网页打印件），以及（2022）京方圆内经证字第 15815 号公证书（其中包含证据 3、5 的网页打印件）。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2022 年 10 月 28 日提交了意见陈述书和反证 1–8 的打印件或复印件，并认为：

（1）涉案专利意外发现，将尼洛替尼分散在一茶匙苹果酱中与以完整胶囊形式服用尼洛替尼是生物等效的，实施例通过比较证实尼洛替尼胶囊和分散在苹果酱中的胶囊内容物是相同的，请求人仅仅是在推测尼洛替尼的剂量和配比可能会影响生物等效性，但未提供任何确凿证据。权利要求 1 明确定义了尼洛替尼分散在苹果酱中，权利要求 1 是清楚的，本领域技术人员可以很容易地区分一项技术方案是否落入权利要求范围内。



(2) 关于新颖性, 第 54130 号无效宣告决定已认定苹果酱对权利要求范围有限定作用, 权利要求 1 相对于证据 3 具有新颖性, 根据一事不再理的原则, 请求人的主张应当予以驳回。请求人只是在形式上提供了不同于第 54130 号无效宣告决定中证据 1 的证据 26, 但其内容实质上是相同的。因此, 基于相同理由, 权利要求 1 相对于证据 26 具有新颖性。

(3) 关于创造性: 和证据 3 相比, 区别技术特征在于涉案专利权利要求 1 涉及包含尼洛替尼和可药用载体、且其中尼洛替尼和可药用载体分散在苹果酱中的制剂的医疗用途。证据 3 中的治疗 CML 的技术效果是未知的, 实际解决的技术问题如第 54130 号决定所认定, 是提供一种与尼罗替尼胶囊产品生物等效、安全从而适合儿童及吞咽困难患者用药的产品的制药用途。涉案专利已经证明尼洛替尼分散在苹果酱中的制剂与胶囊是生物等效的。制剂的稳定性与生物等效性问题无关, 不是涉案专利追求的目的。证据 5, 证据 27 中明确规定 C_{max} 和 AUC 的 90%CI 应落入参比制剂的 80–125% 范围内, 而 T_{max} 则不需要满足该标准。根据涉案专利, 由于酸奶制剂的 C_{max} 的 90%CI 高于 80–125% 的等效范围, 其明显不能满足生物等效性要求。尼洛替尼的生物等效性具有重要意义, 应视为显著且预料不到的技术效果。如第 54130 号无效决定所认定, 证据 3 中没有给出合理的成功预期表明苹果酱制剂可以用于治疗 CML。证据 1 显示尼罗替尼存在浓度依赖性方式延长心脏心室复极, 并教导当 QT 间期显著延长时, 应停止施用尼罗替尼 (参见反证 1)。根据反证 2 至反证 5 涉及的 FDA 和许多其他药物监管机构的相关规定 (参见反证 2 至反证 5) 可知, 黑框警告表示对严重毒副作用甚至危及生命的毒副作用的最高级别警告, 如上所述, 证据 1 所示的 Tasigna 药品说明书中反复警告并加黑框警告表明 Tasigna 必须避免与食物同服, 不得打开胶囊, 应将胶囊作为一个整体服用 (参见反证 1), 因此不会有任何动机将尼洛替尼与任何食物一起施用, 相反是给出了反向教导。证据 5 是 FDA 发布的关于如何设计和开展食物对生物利用度的影响以及餐后生物等效性研究技术指导原则, 证据 5 强调在得出任何结论之前必须要进行研究, 甚至强调研究结果是无法预测的。证据 1 应已按照证据 5 的规定进行全面研究, 基于证据 5 (FDA 指导原则) 的公开内容, 本领域技术人员对于将尼洛替尼分散在苹果酱中与尼洛替尼胶囊是生物等效的、且能够适合地用于治疗 CML 不存在合理的成功预期。证据 2 或证据 26 以及证据 3 没有给出技术启示, 证据 4 至证据 8 均不涉及尼洛替尼, 也未给出技术启示, 参考反证 3 可知, 即使证据 4 表明苹果酱可用于儿童制剂, 也不能得出洒在苹果酱中与药物片剂或胶囊具有生物等效性的结论。

反证 1–8 如下:

反证 1: 第 54130 号无效决定 (针对涉案专利所作出的在先无效决定);

反证 2: 工业指引: 人用处方药和生物产品说明书的警告和注意、用药禁忌和黑框警告部分——内容和格式, 美国卫生与人力服务部、美国食品药品监督管理局、药物审评和研究中心 (CDER)、生物制品审评和研究中心 (CBER), 2011 年 10 月, 英文原文及部分内容的中文译文;

反证 3–1: 关于医疗用医药品的使用上的注意记载要领, (药发第 607 号), 1997 年 04 月 25 日, (对



日本各都道府县知事的日本厚生省药务局长通知），日文原文及部分内容的中文译文；

反证 3-2：关于医疗用医药品说明书的记载要领，1997 年 04 月 25 日，（药安第 59 号），（对日本各都道府县药务主管部（局）长的日本厚生省药务局安全课长通知），日文原文及部分内容的中文译文；

反证 4：加拿大卫生部：指南文件—药品说明书，加拿大卫生部授权公布，批准日为 2013 年 09 月 12 日，生效日为 2014 年 06 月 01 日，英文原文及部分内容的中文译文；

反证 5：国家食品药品监督管理局，国食药监注[2006]202 号，关于印发化学药品和生物制品说明书规范细则的通知及其附件 1-2，发布时间 2006 年 05 月 10 日；

反证 6：欧洲议会和理事会第 1901/2006 号条例（EC），2006 年 12 月 12 日，关于儿科用药和修订条例（欧共体）第 1768/92 号、指令 2001/20 / EC、指令 2001/83/EC 和法规，（EC）726 / 2004，英文原文及部分内容的中文译文；

反证 7：证据 1 补充中文译文；

反证 8：证据 4 补充中文译文。

国家知识产权局本案合议组于 2022 年 11 月 11 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2022 年 12 月 29 日举行口头审理，并于同日将专利权人于 2022 年 10 月 28 日提交的意见陈述书、反证 1-8 的副本转送给了请求人，将请求人于 2022 年 09 月 13 日提交的文件转送给了专利权人。

请求人于 2022 年 12 月 15 日提交了意见陈述书，证据 33-36，以及反证 2、反证 3-1 和反证 4 的补充中文译文。请求人主张：权利要求 1 中并未将活性成分剂量限定为药品说明书所推荐的用量，也没有限定苹果酱的用量，权利要求的技术效果不应等同于具体实施例的技术效果。由证据 32、33、34 可知，尼洛替尼的药代动力学受到苹果酱配比的影响，涉案专利基于唯一一个实施例的结果无法证明整个保护范围都能具有专利权人如上所述的技术效果。涉案专利实施例证明生物等效性所依据的是具有相似的药代动力学参数 $AUC_{0-\infty}$ 和 C_{max} 。而证据 35 记载，在不同剂量的尼洛替尼给药条件下，测得的 $AUC_{0-\infty}$ 和 C_{max} 显著不同（参见表 8），本领域技术人员无法根据 400mg 尼洛替尼的药代动力学数据推断其他剂量的情况，权利要求得不到说明书支持。证据 36 表明，专利权人的原研药品并不在其专利保护范围之内，显示该理解偏离一般认知。基于此认知，权利要求 1 相对证据 26 不具备新颖性。证据 3 公开的技术方案与权利要求 1 完全相同，相对证据 3，权利要求 1 不具备新颖性。在将权利要求 1 “分散在苹果酱中” 理解为制药过程的前提下，反证 2-5 内容并未构成反向教导，以证据 3、证据 2 或证据 26 作为最接近的现有技术，均能得出权利要求 1 不具备创造性的结论。

证据 33-36 如下：

证据 33：尼洛替尼胶囊说明书，2013 年 10 月 10 日；

证据 34：欧洲同族专利 EP 异议程序中专利权人对权利要求的主动修改方案 1，公开日为 2018 年 09 月 27



日，及其中译文；

证据 35：Tasigna（尼洛替尼商品名）：EPAR—科学讨论（Scientific Discussion），公开日为 2007 年 11 月 29 日，及其部分中文译文；

证据 36：北京知识产权法院（2022）京 73 民初 210 号民事裁定书。

请求人于 2022 年 12 月 19 日提交了国家图书馆出具的报告编号为 2022-NLC-GCZM-00512 的馆藏复制证明原件，（2022）京长安内经证字第 35668 号公证书，（2022）京方圆内经证字第 15815 号公证书的公证书原件，（2022）京长安内经证字第 53445 号公证书原件（其中包含证据 33-35 的网页打印件）。

因受新冠疫情影响，经与双方沟通并取得双方同意，国家知识产权局本案合议组于 2022 年 12 月 27 日再次向双方当事人发出了口头审理通知书，取消原定于 2022 年 12 月 29 日举行的口头审理，拟定于 2023 年 01 月 10 日举行远程口头审理，并于同日将请求人于 2022 年 12 月 15 日提交的意见陈述书、证据 33-36 和反证 2、反证 3-1、反证 4 的补充译文的副本转送给了专利权人。

2023 年 01 月 10 日，合议组开展了远程口头审理，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。双方当事人对于对方出庭人员身份和资格无异议，对于合议组成员和书记员没有回避请求，在口头审理过程中，确认并记录了如下事项：

（1）专利权人认可证据 1-36 的真实性，认可请求人所有外文证据和补充反证相关部分内容的译文准确性，同意由合议组代为核实证据 1-36 的原件与复印件是否一致；但主张请求人于 2022 年 12 月 15 日提交的证据中，除提交的相关补充反证译文以外，证据 33-36 均是超期证据，属逾期证据，不应予以接受；并且不认可证据 9 的公开性，并认为证据 11 原文第 1 页左栏倒数第 5 行提交日显示时间是 2009 年 10 月 15 日，因此其只能是 2009 年 10 月 15 日之后文件，公开日并不是 2009 年 06 月 15 日；还指出证据 12、证据 14、证据 22、证据 33、证据 34、证据 36 都是优先权日之后的证据。

（2）专利权人当庭提交了反证 9（证据 1 最后 1 页的补充中文译文）和 4 份供合议组参考的参考资料。请求人对反证 1、反证 7-8，反证 9 真实性无异议，指出反证 3-4 是申请日后公开的文件，不能用以评述新颖性、创造性；不认可反证 2、反证 3-1、反证 3-2、反证 4、反证 5 的关联性。专利权人当庭上传了反证 2-6 的时间戳证明，请求人进行了核实，未提出异议，此外请求人对专利权人提交反证的所有中文译文的译文准确性均无异议。合议组告知请求人可以在口头审理后 3 个工作日内就反证 2-6 的时间戳认证文件、反证 9 补充意见。

口头审理后，请求人未提交意见陈述和新的证据。

2023 年 02 月 07 日，专利权人提交了口审后意见陈述，重申了口头审理时发表的意见，具体指出（1）关于权利要求 1 的理解和新颖性的评价，以及创造性评价中关于现有技术存在反向教导以避免将食物（包括苹果酱）与尼洛替尼一起使用，均应适用“一事不再理”原则。（2）涉案专利所解决的技术问题正如第 54130



号无效宣告决定所述，是提供一种与尼罗替尼胶囊产品生物等效、安全从而适合儿童及吞咽困难患者用药的产品的制药用途。关于请求人质疑的苹果酱不稳定问题，制剂的稳定性与生物等效性无关，不属本发明的发明目的，两种不同技术效果不能混淆。C_{max} 和 AUC 是判断生物等效性的重要因素，尼罗替尼 QT 间期延长的毒副作用是浓度依赖性的，因此 C_{max} 的不等效会导致毒副作用显著增加，酸奶制剂不能满足生物等效性要求。证据 1 和反证 1 教导当 QT 间期显著延长时，应停止施用尼罗替尼，并反复警告不能与食物同服，因此不存在将尼罗替尼和任何食物一起施用的动机，证据 4、证据 5、证据 9-12 及证据 15-16 均未给出得到涉案专利的技术启示。涉案专利中尼罗替尼苹果酱制剂实现了与尼罗替尼胶囊生物等效，属于预料不到的技术效果。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

（一）审查基础

专利权人在无效宣告程序中没有修改权利要求书，因此，本决定的审查基础为涉案专利的授权公告文本。

（二）审查理由和范围

依据请求人的请求，本决定审查的理由和范围是：（1）涉案专利权利要求 1 是否符合专利法第 22 条第 2、3 款的规定；（2）涉案专利权利要求 1 是否能够得到说明书的支持，是否清楚，从而是否符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

（三）证据认定

专利权人对证据 1-36 的真实性均无异议，经核实，合议组亦认可证据 1-36 的真实性。其中，证据 1、4、17、29、35 的公开时间在涉案专利优先权日之前，属于现有技术。虽然证据 35 提交时间超出了 1 个月的期限，但事实上本案中的证据 35 和证据 17 是同一份现有技术的不同部分译文，且对判断本案的相关事实关系重大，如果不予采信将可能得出不合理的结论，证据 17、证据 35 内容涉及的是已知药物尼罗替尼的部分研究数据，合议组对其予以接受。

关于中文译文，双方当事人对相关外文证据的中文译文均无异议，合议组也予以认可。

请求人对反证 1-9 的真实性及相应中文译文均未提出异议，合议组对其真实性和译文准确性亦予以认可。

双方当事人于口头审理当庭及审理后提交的庭后意见、若干份参考资料以及庭审说明演示文稿均未作为证据或反证，仅供合议组参考，合议组对其不再予以认定。

（四）关于专利法第 26 条第 4 款

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

权利要求能够给予保护的范围应当与发明的实际贡献相匹配，以将其与现有技术进行合理划界，以免损害公共利益。判断权利要求的概括是否合理，应客观分析说明书所充分公开的内容并结合本领域技术人员对



现有技术状况的整体理解进行评价，如果权利要求的限定中包含了申请人推测的内容，基于说明书记载即使考虑了本领域技术人员的知识和能力也依然难于预先确定和评价其效果，则不应允许将权利要求扩展至所述保护范围。

权利要求 1 请求保护尼罗替尼在制备用于治疗慢性粒细胞白血病的药物中的用途，其中所述的尼罗替尼和可药用载体分散在苹果酱中。

涉案专利说明书中提供了两个实施例，实施例 1 开展了体外稳定性试验研究，结果显示尼罗替尼分散于酸奶或苹果酱，尼罗替尼在室温下稳定 15 分钟后回收率在 97.6%至 99.9%之间。实施例 2 比较了将尼洛替尼胶囊内容物分散于苹果酱中、酸奶中的施用方式和直接施用尼洛替尼胶囊的生物利用度。18 至 65 岁的 HV 在禁食状态下获得:两粒完整 200 mg 尼罗替尼胶囊的 400 mg 尼罗替尼单次口服施用(治疗 A); 或两粒 200 mg 尼罗替尼胶囊的内容物各自分散在一茶匙无脂肪普通酸奶中的 400 mg 尼罗替尼单次口服施用(治疗 B); 或两粒 200 mg 尼罗替尼胶囊的内容物各自分散在一茶匙苹果酱中的 400 mg 尼罗替尼单次口服施用(治疗 C)。研究结论认为: 将两粒 200 mg 尼罗替尼胶囊内容物各自分散在一茶匙无脂肪普通酸奶中的 400 mg 尼罗替尼单次口服施用，与以完整胶囊提供的 400 mg 尼罗替尼单次口服施用不是生物等效的。将两粒 200 mg 尼罗替尼胶囊内容物各自分散在一茶匙苹果酱中的 400 mg 尼罗替尼单次口服施用，与以完整胶囊提供的 400 mg 尼罗替尼单次口服施用是生物等效的。

双方当事人均认可尼罗替尼作为现有药品具有治疗 CML 的效果，合议组对此予以确认。在此基础上，专利权人强调涉案专利相对于现有技术的贡献在于发现将尼罗替尼分散于苹果酱中，能取得和胶囊的生物等效性，进而据此主张这不会增加潜在的毒副作用。请求人则主张无法预期权利要求 1 范围内的尼罗替尼和苹果酱的任意剂量和配比都能够实现生物等效的技术效果；证据 32-34 显示尼洛替尼的药代动力学受到苹果酱配比的影响，证据 35 显示不同剂量尼洛替尼测得的 AUC_{0-inf} 和 C_{max} 显著不同，无法根据 400mg 尼洛替尼的药代动力学数据推断其他剂量的情况，权利要求 1 得不到说明书支持。

合议组认为，尼罗替尼作为现有药品具有治疗 CML 的技术效果是现有技术已知的，涉案专利要解决的技术问题或者说相对于现有技术的贡献在于发现将 400mg 尼罗替尼分散于一茶匙苹果酱中，能取得和胶囊的生物等效性，合议组对此予以确认。然而，依据涉案专利说明书实施例 2 记载可以看出，针对所选择的 18 至 65 岁的健康志愿者，尼罗替尼胶囊内容物分散在苹果酱与尼罗替尼胶囊实现生物等效的技术手段是将剂量为“两粒 200 mg”的剂型为“尼罗替尼胶囊”的内容物分散在容积为“一茶匙”苹果酱中，并与 400 mg 尼罗替尼胶囊相比。但是目前的权利要求 1 并未限定尼罗替尼的剂量、分散何种剂型中的尼罗替尼、以及苹果酱的分散容积，目前的权利要求 1 范围内所有的技术方案是否均能实现生物等效对于本领域技术人员来说显然是未知的，其原因在于：

申请日前已知晓尼罗替尼存在严重食物效应，禁止与食物同服，且涉案专利实施例 1 的数据显示尼罗替



尼内容物分散在酸奶、苹果酱中后，15 分钟后，其回收率就有可能降低到 97.6%，据此难以认定尼罗替尼内容物分散于苹果酱后能够长期稳定；因此，尼罗替尼分散于苹果酱后的确切体内吸收情况是难以预期的。而是否实现生物等效是通过比较两种制剂的生物利用度来衡量的，特定剂量和剂型下能够取得生物等效是否能够推定到任意常规剂量和剂型都能取得生物等效，并非必然。正如证据 29 所述，生物利用度的影响因素包括剂型因素等（参见证据 29 第 144 页）。依据证据 35 可知，尼罗替尼的剂量和其吸收密切相关，且并未形成规律，尼罗替尼的 C_{max} 和 AUC 存在剂量依赖相关性，其中当尼罗替尼的剂量在 50mg 至 400mg 之间时观察到 C_{max} 和 AUC 增加，甚至相同剂量单纯改变给药次数也会导致体内吸收的显著改变（参见证据 35 第 53 页即中文译文页）。综上可知，不同剂量尼罗替尼的体内生物吸收非常复杂，特定剂量尼罗替尼分散于特定含量苹果酱后的体内吸收和其他剂量尼罗替尼分散于其他含量苹果酱中后的体内吸收，是否均能达到实施例 2 所述的生物等效性，从而避免已知的食物效应对其吸收的严重，是无法预期的。而对于所使用的苹果酱容积，说明书仅仅记载了“一茶匙”，但是“一茶匙”是多大容积并不确定，而且申请日之前已知尼罗替尼的生物利用度明显受到食物影响，因而禁止与食物同服，在食物效应对于尼罗替尼至关重要的前提下，本领域技术人员难以预期当尼罗替尼分散在不同于“一茶匙”容积的苹果酱中时其食物效应到底如何，是否能够实现生物等效难以预期，如果再叠加剂量因素，是否能够实现生物等效更难预料。

因此，基于现有证据，在权利要求 1 并未限定实现生物等效技术效果的技术手段，例如尼罗替尼的剂量、以及苹果酱的分散容积的情况下，仅凭涉案专利实施例 2 无法支持权利要求 1 涵盖的所有技术方案，权利要求 1 包括了无法实现所述生物等效技术效果的技术方案，因此权利要求 1 没有得到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

反证 1-9 不但未否认以上认知，反而进一步确认尼罗替尼的食物效应，禁止与食物同服等认知，因而均不足以证实权利要求 1 能够得到说明书的支持。

如上已得出权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款规定的结论，本案合议组对其他理由和证据不再予以评述。

基于以上事实和理由，合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 201080051819.0 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：王冬

主审员：潘珂

参审员：刘琳

